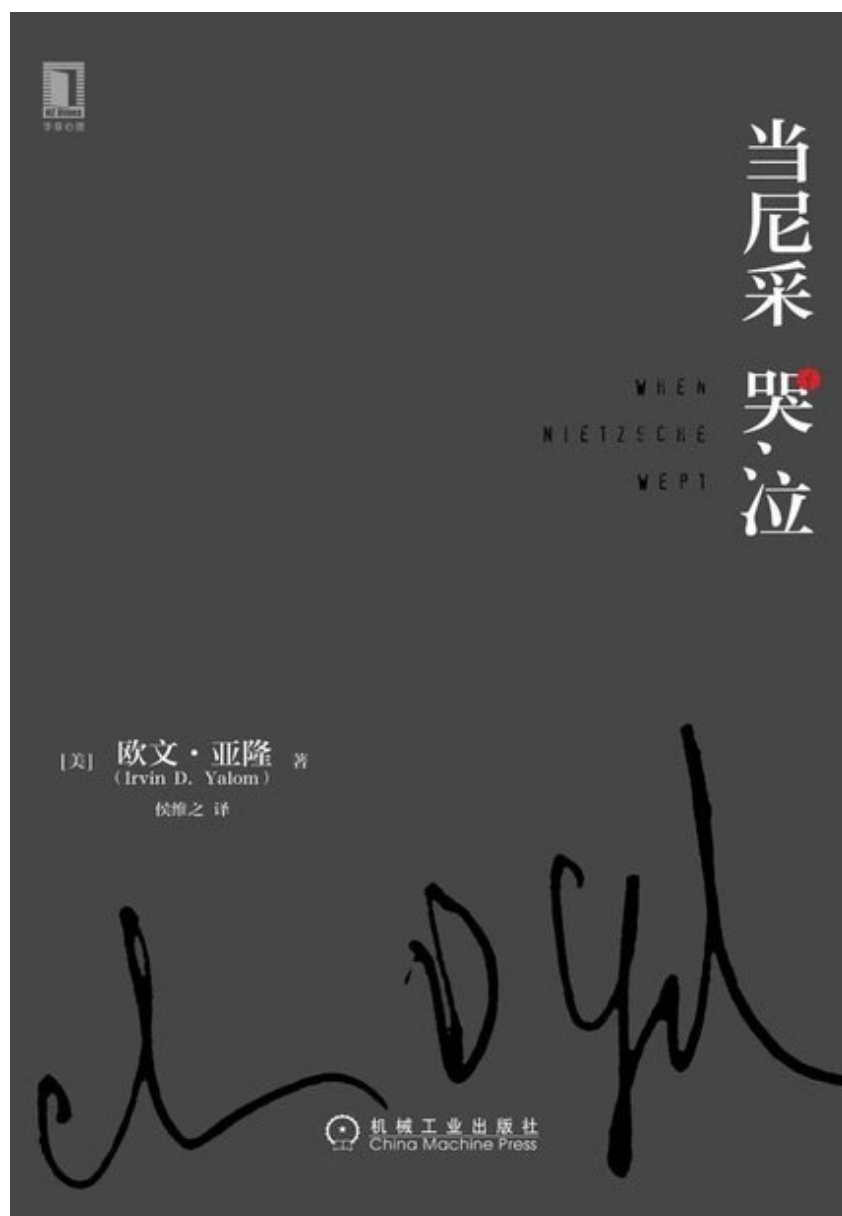


治疗师比病人更需要被治疗

——读欧文·亚隆《当尼采哭泣》

书名：《当尼采哭泣》 | 作者：[美] 欧文·亚隆 (Irvin D. Yalom) | 译者：侯维之 | ISBN：
9787111555377 | 出版社：机械工业出版社，2017年3月 | 页数：392页 | 定价：49.00元 | 豆瓣评分：
8.9



一、一个虚构的相遇

1882年的维也纳。一个叫路·莎乐美的俄国女人找到了约瑟夫·布雷尔医生——维也纳最负盛名的全科医生，弗洛伊德的导师——请他治疗一位陷入绝望的朋友。那个朋友叫弗里德里希·尼采。

尼采当时37岁，还没发疯（那是1889年的事），还没写出《查拉图斯特拉如是说》（那是1883年的事），只是一个在欧洲大学之间流浪的、被女人拒绝过的、头痛发作时把头撞墙的前哲学教授。他不同意被治疗——他认为求助是弱者的标志。

布雷尔接受了这个挑战。但他用的不是药物，而是"谈话治疗"——一种还不存在的疗法。他说服尼采：不是你需要治疗，是我需要你的帮助——我失眠、焦虑、对一个年轻女病人（贝莎）有无法抑制的迷恋，请你用你的哲学智慧帮我。

于是哲学超人变成了治疗师，维也纳名医变成了病人。两个人坐在 Breur 的书房里，一边喝咖啡一边谈论死亡、自由、孤独和人生的意义。

这是欧文·亚隆1931年出生、1992年出版的小说。一个存在主义心理治疗师写的关于存在主义心理治疗诞生过程的虚构故事。

二、四个终极问题

亚隆毕生的理论框架是"存在主义的四大终极关怀"：死亡、自由、孤独、无意义。这四个问题不是病理——不是因为你童年创伤才有的——而是你活着就逃不掉的。

《当尼采哭泣》把这四个问题全部装进了一个故事里：

- 死亡：布雷尔40岁，开始感到衰老。他的父亲死了，他的导师去世了，他自己也在走向终点。他怕的不是死，是"没有真正活过就死了"。- 自由：布雷尔被困在一段体面的婚姻、一个成功的诊所、一种所有人都需要他的生活里。他有自由选择一切，但他什么都没选——他只是被惯性推着走。- 孤独：尼采说"孤独只存在于孤独之中，一旦分担，它就蒸发了"。但布雷尔和尼采都发现，真正亲密的关系需要你先能独处——如果你不能像一只老鹰一样不需要任何观众，你就只是在利用他人作为对抗孤立的挡箭牌。- 无意义：尼采的整个哲学就是在回答这个问题。如果上帝死了，如果旧的价值体系崩塌了，你凭什么活下去？尼采的答案是：创造你自己的价值。但布雷尔问了一个更尖锐的问题：你创造了价值，然后呢？你还是会死，你创造的一切都会消失。

这四个问题没有答案。亚隆不给答案——他给的是一个对话的空间。在对话中，两个人都不是治疗师，也都不是病人。他们是两个被存在问题困住的普通人，只不过一个用哲学语言说话，一个用医学语言说话。

三、布雷尔和贝莎：欲望是欲望的替代品

布雷尔对贝莎的迷恋是全书最精巧的设计。

贝莎是布雷尔的真实病人——历史上"安娜·欧"案例的原型，精神分析史上第一个"谈话治疗"的对象。在小说里，布雷尔对贝莎的迷恋不是爱情，是对死亡的恐惧投射。贝莎年

轻、充满活力、需要他——在贝莎眼中，布雷尔不是衰老的中年医生，而是拯救者。贝莎给布雷尔的不是爱，是一面让他看不到衰老的镜子。

亚隆在这里揭示了一个存在主义的深层机制：当我们无法面对死亡和衰老时，我们会把恐惧转化为欲望。布雷尔迷恋贝莎，不是因为他不爱妻子，是因为贝莎让他觉得自己还活着——而"觉得自己还活着"恰恰说明他觉得自己正在死去。

尼采看到了这一点。他问布雷尔："你的欲望不是对贝莎的欲望，是对青春的欲望。贝莎只是你借来对抗时间的一面盾牌。"

这比任何药都有效。

四、治疗师的盲区

亚隆自己是斯坦福大学的精神科教授，一辈子做心理治疗。他比谁都清楚：治疗师最容易犯的错误是以为自己没有问题。

布雷尔是维也纳最好的医生，所有人都来找他看病，他从不怀疑自己需要被治疗。直到尼采——一个从不看医生的人——成了他的"病人"，他才发现：治疗师和病人的区别不是健康与疾病，而是谁先承认自己有问题。

弗洛伊德在小说里是布雷尔的年轻学生，27岁，还没有创立精神分析。他崇拜布雷尔，但布雷尔不向他袒露内心——因为向学生袒露意味着承认自己不够格当老师。布雷尔的困境是所有专业人士的困境：你越专业，越不敢承认自己有病。

亚隆写这本书的勇气在于：他把心理治疗的"祖师爷"写成了一个有病的人。布雷尔的历史原型真的治疗过"安娜·欧"，真的和弗洛伊德合作过——但亚隆虚构了他被尼采"反向治疗"的过程，以此说明：治疗不是治疗师对病人做的事，是两个人一起面对存在的方式。

五、尼采和Amor Fati

尼采的哲学核心之一是"命运之爱"（Amor Fati）——不是忍受命运，不是接受命运，是热爱命运。热爱你的痛苦、你的孤独、你的失败、你的衰老——因为这些都是你的，而你只有一个人人生。

小说最后，布雷尔在催眠中经历了一次"死亡"——他看到自己死后妻子改嫁、诊所易主、贝莎忘了她。他发现：他害怕的不是死亡，是不存在——没有人记得他存在过。从催眠中醒来后，他找回了对妻子的爱，接受了自己的衰老，放下了对贝莎的迷恋。

尼采也哭了。不是因为悲伤，是因为他第一次被理解了——被一个不是哲学家的人，用对话而不是用文本理解了。他一生孤独，说"我不是人，我是炸药"，但在那个维也纳的书房里，他短暂地做回了一个普通人。

"选择你的命运，热爱你的命运。"这不是鸡汤——这是尼采用一生（和一个崩溃）换来的结论。

六、和之前书评的交叉引用

和《自卑与超越》阿德勒： 昨天评的。阿德勒说自卑是动力——你因为不够好所以努力。亚隆说得更深：你怕的不是不够好，是不存在。阿德勒的自卑是"我和别人比"，亚隆的存在焦虑是"我和虚无比"。阿德勒给你动力，亚隆给你清醒。两本可以一起读：阿德勒帮你活，亚隆帮你活明白。

和《个体的价值与命运》鲍桑葵： 昨天评的。鲍桑葵说"个体只有在整体中才能完成"——个体的价值不在个体自身，在它和整体的关系里。亚隆的故事是这个哲学的临床版：布雷尔和尼采各自是孤独的个体，但在对话中——在两个人的"整体"里——各自完成了自己。治疗不是个体的事，是关系的事。

和《当下的力量》托利： 昨天评的。托利说"活在当下"——不要被过去和未来绑架。亚隆说的几乎是同一件事的另一面：你不能不想到死亡，但你可以选择怎么面对它。托利的方法是冥想，亚隆的方法是对话。托利让你离开时间，亚隆让你进入时间。

和Sara Imari Walker《科学家的消亡》： 刚评的。Walker说科学家发表论文时"死了"——把作品交给社会去解释。亚隆做的是反过来：治疗师在对话中"活了"——不是发表作品，而是在关系中暴露自己。科学的主体间性是文本的，心理治疗的主体间性是肉身的。你不能和一个文本辩论，但你可以和一个人哭泣。

七、一句话

治疗师比病人更需要被治疗——因为承认自己有问题，比治愈别人难一万倍。

大米斗，2026年9月

